

엠펙리스오토인젝터주(레브리키주맵, 유전자재조합)(한국릴리(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1오토인젝터 중 Lebrikizumab 250mg
제형 및 성상	무색에서 약간 노란색 또는 약간 갈색이며, 육안으로 보이는 미립자가 없는 투명에서 유백광의 용액이 든 주사침이 부착된 투명한 시린지가 일회용 펜에 장착된 주사제
효능·효과	성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg 이상)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증의 아토피 피부염의 치료
용법·용량	치료는 아토피 피부염의 진단 및 치료 경험이 있는 전문 의료인에 의해 시작되어야 한다. 1. 성인 및 청소년(체중이 최소 40kg인 12세 이상) : 이 약의 권장 용량은 500mg(250mg 2회 주사)을 0주차 및 2주차에 투여하고, 이후 16주차까지 250mg을 2주 간격으로 피하 투여한다. 16주 투여 후 임상 반응을 나타내지 않는 환자에 대해서는 투여 중단을 고려해야 한다. 초기에 부분 반응을 나타내는 일부 환자들은 24주차까지 2주 간격으로 투여를 계속하면 추가로 개선될 수 있다. 임상 반응을 달성하면, 이 약의 권장 유지 용량은 4주마다 250mg이다. 이 약은 단독으로 또는 국소 코르티코스테로이드와 병용으로 투여할 수 있다. 국소 칼시뉴린 저해제를 사용할 수 있으나, 얼굴, 목, 접힘 부위 및 생식기 부위 같은 문제가 되는 부위에만 사용하도록 한다. 2. 투여를 놓친 경우 : 투여를 잊었을 경우, 가능하면 빨리 놓친 용량을 투여해야 한다. 이후 예정된 시간에 투여를 재개해야 한다.
의약품 분류 ATC	142, 자격요법제(비특이성면역억제제를 포함) D11AH10
약리기전	인터루킨-13(IL-13)에 결합하는 면역글로불린(IgG4) 단일 클론 항체 - IL-4 수용체 알파(IL-4Rα)/IL-13 수용체 알파 1(IL-13Rα1) 헤테로다이머 수용체 신호 전달 복합체의 형성을 방해하여 IL-13의 신호 전달 억제
품목허가일	2024년 8월 5일

(1) 대상 질환의 특성

○ 아토피피부염(Atopic Dermatitis)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾

- (개요) 아토피피부염은 유전적인 알레르기 반응에 의해 피부에 염증이 생겨 오랜 시간 지속되는 만성 염증성 피부질환으로, 대개 생후 2-3개월의 어린 아이들에게서 나타나지만 성인기까지 지속되거나 성인기에 발병할 수도 있음.
- (역학) 주로 영유아기에 흔히 나타나지만 성인기까지 지속되거나 성인기에 새로 발병할 수도 있음. 전 세계적으로 아토피피부염의 유병률은 증가하고 있으며, 약 15-23%로 추정됨. 우리나라에서는 소아의 10-20%, 성인의 1-3% 정도가 아토피피부염을 앓고 있는 것으로 추정됨.
- (원인) 아토피피부염의 원인은 명확히 밝혀지지 않았으나 유전적인 소인과 환경적인 요인, 면역학적 이상과 피부 보호막 역할을 하는 피부 장벽 기능의 이상 등 요인들의 복잡한 상호 작용에 의해 발생하는 것으로 생각하고 있음.
 - 면역 조절 이상으로 후천적으로 Th2 매개 반응으로 IL-4, 5, 13, 31, IgE가 증가하여 급성 반응이 나타나고, Th1, Th17, Th22 매개 반응으로 IL-12, IFN γ 가 증가하여 만성 반응이 나타남.
 - 피부 장벽 기능의 이상으로 많은 환자들에서 필라그린(filaggrin) 단백질을 암호화하는 유전자의 돌연변이가 관찰됨.
- (진단) 아토피피부염의 진단은 임상 증상과 병력 조사, 검사 소견을 종합하여 이루어지며, 임상적 중증도 평가는 신체 각 부위의 홍반(붉은 정도), 부종 및 구진, 긁은 상처, 태선화를 평가하는 ‘습진 면적 및 중증도 지수(EASI)’가 주로 쓰임. 이외에도, 알레르기 검사, 총 혈청 IgE 검사 등을 실시할 수 있음.
- (치료) 일반적인 아토피피부염 치료에 반응이 없거나 심한 아토피피부염 환자의 경우 생물학제제, 사이클로스포린과 같은 전신 면역 조절제, 자외선 치료와 같은 광선 치료를 사용하는 전신 치료를 할 수 있음.
 - 국소 스테로이드 연고, 국소 칼시뉴린 억제제 등에 반응이 잘 나타나지

1) 질병관리청. 국가건강정보포털(<https://health.kdca.go.kr/healthinfo/>). 건강정보 > 아토피피부염

2) Goldman-Cecil Medicine, 27e. 2024

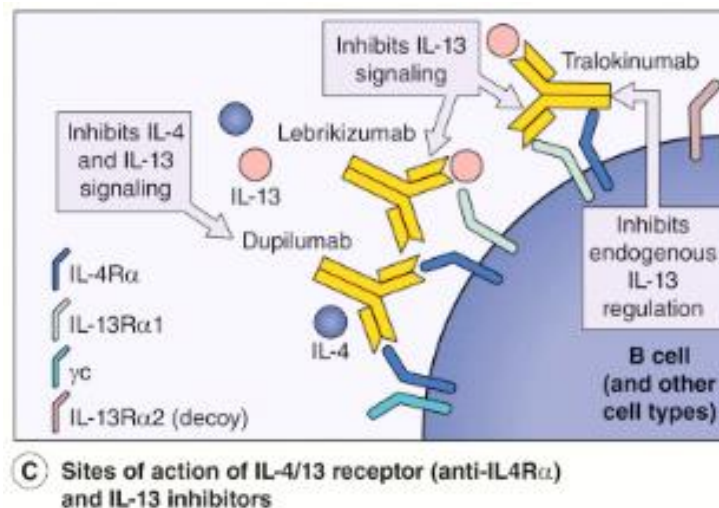
3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. 2022

4) Dermatology. 5e. 2025

않는 경우, PDE-4 억제제, JAK inhibitor(abrocitinib, upadacitinib), 생물학적 제제로 IL-4 receptor α -antagonist(dupilumab), IL-13 receptor blocker(tralokinumab) 등의 치료를 고려할 수 있음.

(2) 약제 특성5)

- 신청품은 ‘성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg 이상)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증의 아토피 피부염의 치료’에 허가받은 생물의약품으로, 인터루킨-13(IL-13)에 결합하는 면역글로불린(IgG4) 단일 클론 항체로 IL-4 수용체 알파(IL-4R α)/IL-13 수용체 알파 1(IL-13R α 1) 헤테로다имер 수용체 신호 전달 복합체의 형성을 방해하여 IL-13의 신호전달을 억제함.



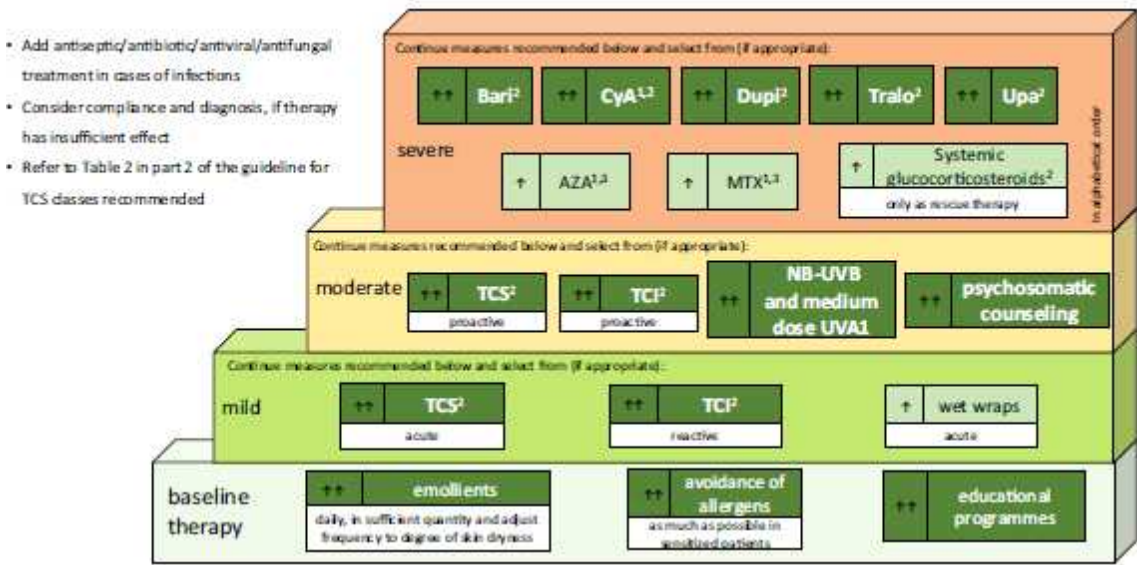
(3) 교과서 및 임상진료지침

○ 신청품은 교과서⁶⁾⁷⁾ 및 임상진료지침⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 IL-13에 선택적으로 작용하는 인간화 IgG4 단일 클론 항체로 아토피피부염의 치료에 대하여 임상시험이 진행 중인 약제로 소개되고 있으며, 국소 치료제로 적절히 조절되지 않거나 권장되지 않는 중등증 이상의 아토피피부염 환자의 전신 치료로 사용할 것을 제안하고 있음.

– European guideline(EuroGuiDerm) on atopic eczema(2022)

- 신청품의 진행 중인 임상시험에서 위약 대비 EASI score 등에서 개선을 보였으며, dupilumab 대비 낮은 결막염 부작용 발생률을 보인다고 언급함.

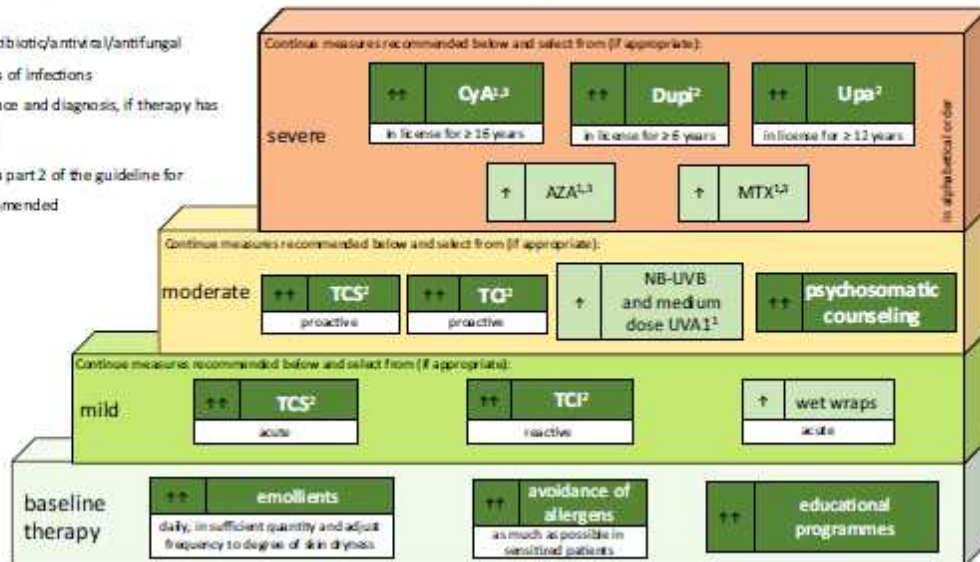
Stepped-care plan for adults with atopic eczema



6) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023
7) Dermatology. 5e. 2025
8) Wollenberg A, et al. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I – systemic therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022;36(9):1409-1431.
9) 대한아토피피부염학회. 2024 한국 아토피피부염 치료 가이드라인 중등증/중증 아토피피부염 약물치료 최신 업데이트. 2024
10) 대한소아알레르기호흡기학회. 소아청소년 아토피피부염 진료지침. 2023

Stepped-care plan for children and adolescents with atopic eczema

- Add antiseptic/antibiotic/antiviral/antifungal treatment in cases of infections
- Consider compliance and diagnosis, if therapy has insufficient effect
- Refer to Table 2 in part 2 of the guideline for TCS classes recommended



– 2024 한국 아토피피부염 치료 가이드라인(2024)

- 국소 치료제로 적절히 조절되지 않거나 권장되지 않는 중등증 이상의 성인 아토피피부염 환자에서 신청품의 사용을 고려할 것을 제안하였으며(권고 강도:B, 근거 수준:1b), 성인 및 청소년 아토피피부염 환자를 대상으로 신청품의 임상시험이 유망한 결과를 보였음을 언급함.

(4) 임상 시험 결과

- 신청품의 임상 연구 논문으로 무작위배정 비교임상시험을 대상으로 한 체계적 문헌고찰 3편과, 간접비교 문헌(MAIC) 1편, 무작위배정 비교임상시험 3편, 단일군 임상시험 1편을 검토함.

(가) 신청품 임상시험

- [ADvocate1/2-16주]¹¹⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나 부적절한 중등도에서 중증 아토피피부염¹²⁾ 18세 이상 성인 및 12세 이상 청소년(40kg 이상) 환자를 대상으로 한(ADvocate1 424명, ADvocate2 427명) 무작위배정(2:1), 이중맹검, 위약대조, 3상 임상시험인 ADvocate1과 ADvocate2 결과¹³⁾,
 - [1차 평가지표] 16주차 IGA 점수¹⁴⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 위약군 대비 신청품군에서 높았으며, ADvocate1에서 신청품군 43.1%, 위약군 12.7%(두 군간 차이 29.7%, 95% CI 21.6-37.8, p<0.001), ADvocate2에서 신청품군 33.2%, 위약군 10.8%(두 군간 차이 21.9%, 95% CI 14.2-29.6, p<0.001)로 나타남.
 - [2차 평가지표] 16주차 EASI-75¹⁵⁾ 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군에서 높았으며, ADvocate1에서 신청품군 58.8%, 위약군 16.2%(두 군간 차이 42%, 95% CI 33.3-50.6, p<0.001), ADvocate2에서 신청품군 52.1%, 위약군 18.1%(두 군간 차이 33.3%, 95% CI 24.4-42.2, p<0.001)로 나타남.
 - 16주차까지 rescue medication을 받은 환자 비율은 ADvocate1에서 신청품군 11%, 위약군 33.3%, ADvocate2에서 신청품군 18.5%, 위약군 39.7%이었음.

11) Silverberg JI, et al. Two Phase 3 Trials of Lebrikizumab for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2023;388(12):1080-1091.

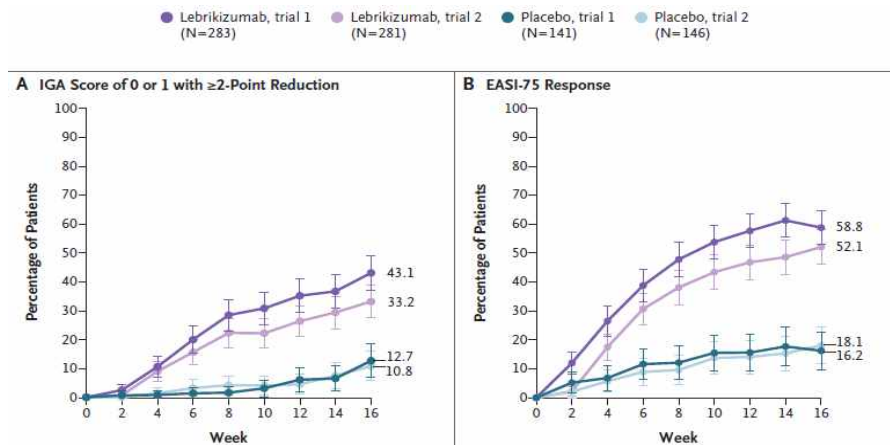
12) EASI score 16 이상, IGA score 3점 이상, BSA 10% 이상, 국소치료제 사용에도 최소 1년 이상 지속되는 만성 아토피피부염

13) lebrikizumab every 2weeks(loading dose of 500mg baseline and week 2, 이후 250mg Q2W), placebo every 2weeks

14) IGA score(Investigator’s Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)

15) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease.

EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선



– [안전성] 부작용 발생률(TEAEs)은 ADvocate1에서 신청품군 45.7%, 위약군 51.8%, ADvocate2에서 신청품군 53.4%, 위약군 66.2%이었으며, 신청품 또는 위약의 중단으로 이어진 부작용은 ADvocate1에서 신청품군 1.1%, 위약군 0.7%, ADvocate2에서 신청품군 3.2%, 위약군 2.8%이었음.

- 결막염은 ADvocate1에서 신청품군 7.4%, 위약군 2.8%, ADvocate2에서 신청품군 7.5%, 위약군 2.1%로 신청품군에서 더 빈번히 나타남.

○ [ADvocate1/2-52주]¹⁶⁾ 16주 이후 신청품 치료에 반응이 있는 환자 (n=291)를 대상으로 신청품군 2주 간격(Q2W) 요법군(n=113), 4주 간격(Q4W) 요법군(n=118), 위약군(PBO, n=60)¹⁷⁾으로 무작위배정(2:2:1)한 이중맹검, 병렬, 위약대조 3상 임상시험 결과¹⁸⁾,

16) Blauvelt A, et al. Efficacy and safety of lebrikizumab in moderate-to-severe atopic dermatitis: 52-week results of two randomized double-blinded placebo-controlled phase III trials. Br J Dermatol. 2023;188(6):740-748.

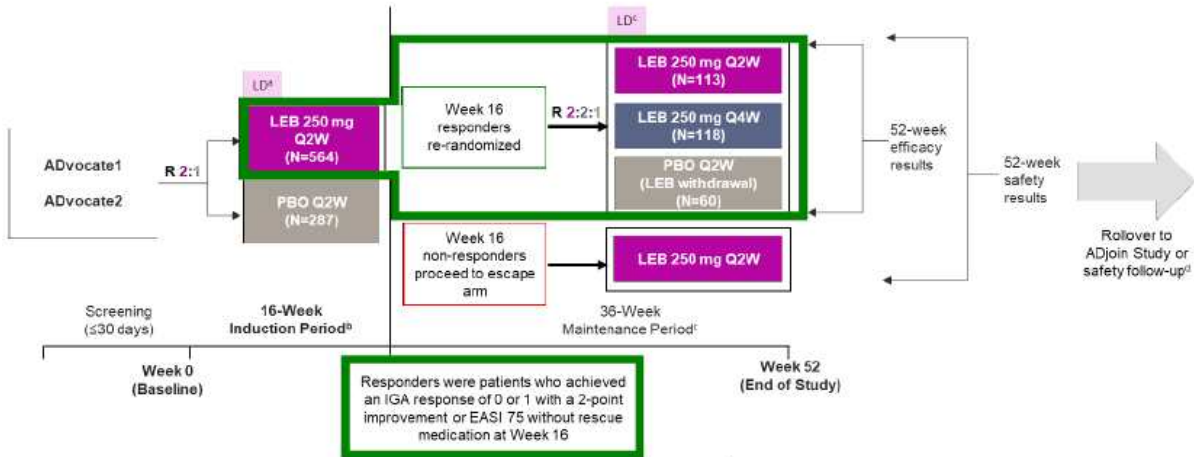
17) 위약군:16주 연구에서 반응이 있는 환자 중 re-randomization을 통하여 LEB withdrawal군으로 배정

18) ADvocate1과 ADvocate2의 pooled mMPP(modified maintenance primary population) analysis 결과

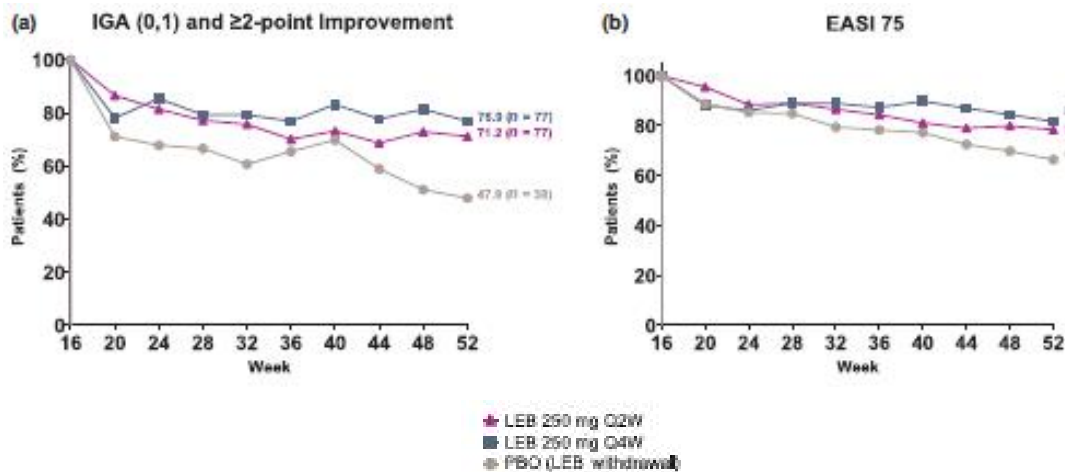
MPP: All patients who were randomized to lebrikizumab Q2W at baseline visit and re-randomized to lebrikizumab Q2W, lebrikizumab Q4W, or placebo (lebrikizumab withdrawal) at Week 16 and received at least 1 dose of study treatment during the maintenance period.

mMPP: MPP excluding all patients from a single study site whose eligibility of moderate-to-severe AD could not be confirmed.

Figure S1: Study Design for ADvocate1 and ADvocate2



- [1차 평가지표] 52주차 IGA 점수¹⁹⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 신청품 Q2W군 71.2%, Q4W군 76.9%, 위약군 47.9%로 신청품군에서 52주차까지 치료효과가 더 높게 유지되는 것으로 나타남.
- [2차 평가지표] 52주차 EASI-75²⁰⁾ 달성 환자 비율은 신청품 Q2W군 78.4%, Q4W군 81.7%, 위약군 66.4%로 신청품군에서 더 높게 나타남.
 - 52주차까지 rescue medication을 받은 환자 비율은 신청품 Q2W군 12.4%, Q4W군 16.1%, 위약군 18.3%이었음.



- [안전성] 부작용 발생률은 ADVOCATE1에서 신청품 Q2W군 49.6%, Q4W군 51.7%, 위약군 50%이었으며, 신청품 또는 위약의 중단으로 이어진 부작용은 신청품 Q2W군 0.9%, Q4W군 1.7%, 위약군 0%이었음.

19) IGA score(Investigator's Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)

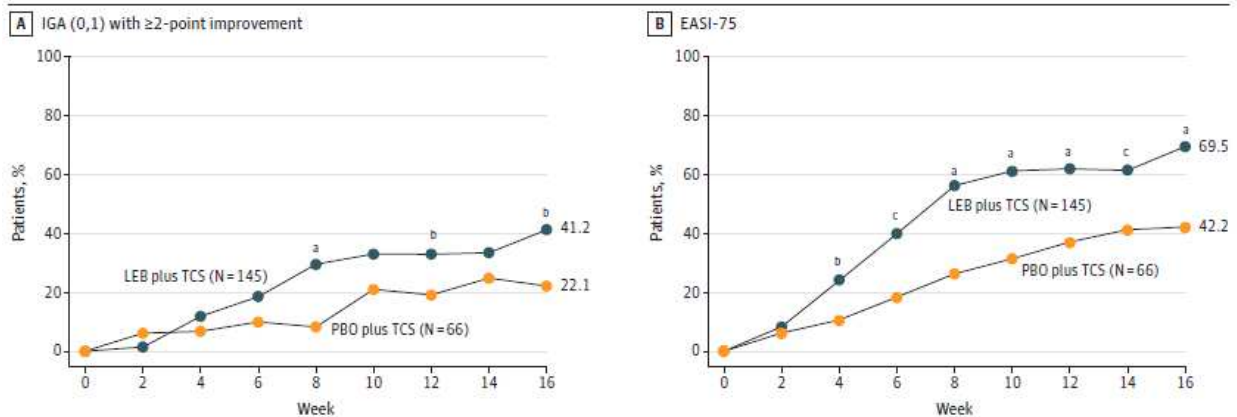
20) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease.

EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선

- 결막염은 신청품 Q2W군 1.8%, Q4W군 5.9%, 위약군 3.3%로 신청품군에서 더 빈번히 나타남.

- [ADhere-16주]²¹⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나 부적절한 중등도에서 중증 아토피피부염²²⁾ 18세 이상 성인 및 12세 이상 청소년(40kg 이상) 환자를 대상(n=211)으로 위약(PBO+TCS, n=66)대비 신청품과 저/중등도 국소 코르티코스테로이드 병용(LEB+TCS, n=145)의 효과를 평가하기 위한 무작위배정(2:1), 이중맹검, 다기관, 위약대조 3상 임상시험 결과²³⁾,
 - [1차 평가지표] 16주차 IGA 점수²⁴⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 LEB+TCS군 41.2%, PBO+TCS군 22.1%(두 군간 차이 18.3%, 95% CI 5.1-31.5, p=0.01)로 위약군 대비 신청품과 TCS 병용군에서 통계적으로 유의하게 높았음.
 - [2차 평가지표] 16주차 EASI-75²⁵⁾ 달성 환자 비율은 LEB+TCS군 69.5%, PBO+TCS군 42.2%(두 군간 차이 26.4%, 95% CI 12.4-40.8, p<0.001)로 위약군 대비 신청품과 TCS 병용군에서 통계적으로 유의하게 높았음.
 - 16주차까지 rescue medication을 받은 환자 비율은 LEB+TCS군 4.1%, PBO+TCS군 10.6%이었음.

Figure 2. Time-Course Response for the Clinical Outcomes (Primary and Secondary End Points)



21) Simpson EL, et al. Efficacy and Safety of Lebrikizumab in Combination With Topical Corticosteroids in Adolescents and Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Randomized Clinical Trial (ADhere). JAMA Dermatol. 2023;159(2):182-191.

22) EASI score 16 이상, IGA score 3점 이상, BSA 10% 이상, 국소치료제 사용에도 최소 1년 이상 지속되는 만성 아토피피부염

23) lebrikizumab every 2weeks (loading dose of 500mg baseline and week 2, 이후 250mg Q2W)+low-mid potency TCS : placebo+low-mid potency TCS = 2:1

24) IGA score (Investigator's Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)

25) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease.

EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선

- [안전성] 부작용 발생률은 LEB+TCS군 43.4%, PBO+TCS군 34.8%이었으며, 신청품 또는 위약의 중단으로 이어진 부작용은 LEB+TCS군 2.1%, PBO+TCS군 0%이었음.

- 결막염은 LEB+TCS군 4.8%, PBO+TCS군 0%로 신청품군에서 더 빈번히 나타남.

○ [ADore-52주]²⁶⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나 부적절한 중등도에서 중증 아토피피부염²⁷⁾ 12세 이상, 18세 미만 청소년(40kg 이상) 환자를 대상(n=206)으로 한 52주, open-label, 단일군 3상 임상시험 결과²⁸⁾,

- [안전성] 부작용 발생률(TEAEs)은 65%(134/206)이었으며, 대부분 mild-moderate 수준이었음. 중대한 이상반응(SAEs)은 2.4%(5/206)이었고, 치료중단으로 이어진 이상반응 발생률은 2.4%(5/206)로 나타났으며, 결막염 발생률은 6.8%(14/206)이었음.

- [유효성] 52주차 IGA 점수²⁹⁾가 0/1이면서 기저치 대비 2점 이상 감소한 환자의 비율은 62.6%(129/206)이었고, 52주차 EASI-75³⁰⁾ 달성 환자 비율은 81.9%(169/206)이었음.

26) Paller AS, et al. Safety and Efficacy of Lebrikizumab in Adolescent Patients with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A 52-Week, Open-Label, Phase 3 Study. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2023;13(7):1517-1534.

27) EASI score 16 이상, IGA score 3점 이상, BSA 10% 이상, 국소치료제 사용에도 최소 1년 이상 지속되는 만성 아토피피부염

28) lebrikizumab loading dose 500mg week 0, 2, 이후 lebrikizumab 250mg Q2W ~52wk

29) IGA score(Investigator's Global Assessment score): 조사자 종합 평가, range from 0 (clear skin) to 4 (severe disease)

30) Eczema Area and Severity Index (EASI) assesses four signs of disease (erythema, papulation or edema, excoriation, and lichenification) across four body regions. The composite score ranges from 0 to 72, with higher values indicating a greater severity and extent of disease.

EASI-75 response: 기저치 대비 EASI score 75% 이상 개선

(나) 무작위배정 비교임상시험을 대상으로 한 체계적 문헌고찰

- [AAAAI/ACAAI³¹⁾, NMA]³²⁾ 2022년 11월 29일까지 검색된 아토피피부염의 전신 및 광선치료의 무작위배정 시험 중 75개의 중재법을 평가한 149개 시험을 포함하여 중등도에서 중증 아토피피부염 28,686명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,
 - (생물학적 제제) 신청품을 포함한 생물학적 제제들은 중등도의 효과를 보였으며, 특히 신청품과 dupilumab은 수면장애 개선 효과가 가장 좋은 것으로 나타남. 또한, 유의미한 부작용 발생 빈도의 증가는 없었으나, 결막염 발생이 약간 증가하였음.
 - (JAK 억제제) 고용량 upadacitinib이 환자에게 중요한 결과(patient-important outcomes)³³⁾ 6가지 중 5가지에서 가장 효과적이었으며, 고용량 abrocitinib 및 저용량 upadacitinib이 2가지 결과에서 가장 효과적으로 나타났으나, 이러한 JAK 억제제들은 이상반응 증가 측면에서 가장 유해하였음.
 - (면역억제제 등) azathioprine, 경구 corticosteroids, cyclosporine, methotrexate, mycophenolate, 광선치료 등의 효과와 안전성에 대한 근거 수준은 상대적으로 낮음.

31) American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI) and American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI)

32) Chu AWL, et al. Systemic treatments for atopic dermatitis (eczema): systematic review and network meta-analysis of randomized trials. J Allergy Clin Immunol. 2023 Sep 5:S0091-6749(23)01112-0.

33) ① Clinician-reported atopic dermatitis severity (Eczema Area and Severity Index, EASI) ② Patient-reported atopic dermatitis severity (Patient-Oriented Eczema Measure, POEM) ③ Itch severity (Numeric Rating Scale, NRS) ④ Sleep disturbance (NRS) ⑤ AD-related quality of life (Dermatology Life Quality Index, DLQI) ⑥ Atopic dermatitis flares (exacerbations)

	Atopic Dermatitis Severity EASI (0-72)	Patient-Reported AD Severity POEM (0-20)	Itch NRS (0-10)	Sleep Disturbance NRS (0-10)	Eczema-Related Quality of Life 3LQ (0-30)	Atopic Dermatitis Flare BDI (0-100)	Any Adverse Event BDI (0-100)	Serious Adverse Event BDI (0-100)
Reference	MD (95% CrI)	MD (95% CrI)	MD (95% CrI)	MD (95% CrI)	MD (95% CrI)	BDI (95% CrI)	BDI (95% CrI)	BDI (95% CrI)
	-2.00	-2.02	-1.10	-1.10	-1.34	139 per 1000	392 per 1000	22 per 1000
Cytotoxic and Immunophilin Agents								
Azathioprine	-4.95 (-9.70 to -0.22)		-1.41 (-2.75 to -0.06)	-1.30 (-2.68 to 0.08)	-3.05 (-6.30 to 0.19)	-108 (-239 to 648)	193 (-541 to 436)	5 (-21 to 85)
Cyclosporin 4-5mg/kg (High Dose)	-13.38 (-17.01 to -9.85)		-2.05 (-3.70 to -0.39)	-1.45 (-2.17 to -0.58)	-8.34 (-12.54 to -4.11)		215 (22 to 524)	0 (-18 to 87)
Cyclosporin 2-3mg/kg (Low Dose)	-6.73 (-10.96 to -2.52)		-0.96 (-1.81 to -0.14)	-0.12 (-0.97 to 0.68)	-5.39 (-9.81 to -0.97)	0 (-136 to 787)	136 (-206 to 254)	23 (-18 to 516)
Methotrexate	-6.88 (-11.01 to -2.88)		-1.30 (-3.40 to 0.79)	-0.30 (-2.23 to 1.13)	-3.87 (-7.40 to 0.07)	-86 (-138 to 672)	177 (-254 to 343)	3 (-21 to 966)
Mycophenolate	-8.71 (-16.69 to -0.74)							
Monoclonal Antibodies								
Astegolimab	4.47 (-5.17 to 14.10)		0.96 (-1.20 to 2.54)			-64 (-122 to 113)	-168 (-377 to 71)	27 (-19 to 591)
Benralizumab	8.13 (-10.79 to 10.99)							
Dupilumab 300mg Q2W (Standard Dose)	-10.72 (-12.35 to -9.19)	-7.69 (-7.94 to -6.90)	-2.14 (-2.18 to -1.90)	-1.84 (-2.26 to -1.42)	-4.56 (-5.18 to -3.98)	-74 (-83 to -64)	-20 (-50 to 10)*	-11 (-14 to -7)
Fexakinumab	-4.96 (-13.97 to 4.02)						-52 (-112 to 88)	34 (-19 to 539)
IgEkinumab	-1.82 (-1.33 to 3.68)		-1.30 (-2.34 to 0.13)			-53 (-105 to 37)		-13 (-21 to 55)
Lebrikizumab 250mg Q2W (Standard Dose)	-9.50 (-12.36 to -6.64)	-8.10 (-9.40 to -6.76)	-1.77 (-2.22 to -1.24)	-1.39 (-2.09 to -0.66)	-3.32 (-5.55 to -1.31)	-73 (-124 to 108)	70 (-48 to 171)*	-15 (-20 to 12)
Mepolizumab	-3.48 (-9.09 to 2.91)	-4.23 (-5.30 to -3.13)	-1.30 (-3.03 to 0.41)				-307 (-512 to -126)	-2 (-21 to 409)
Reslizumab	-3.40 (-7.36 to 0.52)	-4.77 (-7.28 to -2.35)	-2.16 (-2.88 to -1.44)	-1.70 (-2.41 to -1.05)	-1.95 (-3.40 to -0.49)	1 (-62 to 66)	38 (-52 to 121)	4 (-13 to 81)
Omalizumab	0.13 (-6.78 to 7.23)	-0.51 (-3.59 to 2.51)			-0.91 (-6.76 to 4.92)	0 (-304 to 134)	80 (-117 to 328)	0 (-13 to 31)
Tecopelumab	-2.13 (-6.56 to 2.68)		-0.97 (-1.36 to -0.58)				-66 (-258 to 118)	-8 (-18 to 37)
Tralokinumab 300mg Q2W (Standard Dose)	-6.45 (-8.67 to -4.23)	-4.47 (-5.37 to -3.58)	-1.06 (-1.51 to -0.65)	-0.93 (-1.36 to -0.49)	-2.36 (-3.21 to -1.51)	-57 (-72 to -40)	-1 (-43 to 40)*	-8 (-13 to 1)
Ustekinumab	1.38 (-5.01 to 8.77)		0.03 (-2.49 to 1.38)		-0.60 (-2.82 to 1.67)	-87 (-121 to 53)	-102 (-137 to 137)	-5 (-21 to 191)
Oral JAK Inhibitors								
Abrociclitinb 200mg (High Dose)	-9.44 (-11.90 to -6.98)	-7.70 (-8.23 to -6.51)	-2.22 (-2.62 to -1.83)	-1.74 (-2.17 to -1.29)	-4.56 (-5.19 to -3.71)	-121 (-177 to -114)	83 (45 to 122)*	0 (-10 to 18)
Abrociclitinb 100mg (Low Dose)	-6.89 (-9.49 to -4.28)	-4.69 (-5.52 to -3.74)	-1.40 (-1.82 to -0.99)	-0.96 (-1.40 to -0.51)	-2.81 (-3.73 to -1.92)	-85 (-105 to -78)	5 (-42 to 51)*	-2 (-11 to 16)
Baricitinib 2-4mg (High Dose)	-5.99 (-8.78 to -3.22)	-4.31 (-5.61 to -3.39)	-1.24 (-1.71 to -0.77)	-1.30 (-1.80 to -0.80)	-2.80 (-3.78 to -1.81)	-69 (-114 to 40)	60 (18 to 99)*	-6 (-13 to 61)
Baricitinib 1mg (Low Dose)	-3.47 (-6.81 to -0.12)	-2.21 (-3.60 to -0.80)	-0.69 (-1.27 to -0.11)	-0.91 (-1.52 to -0.29)	-1.48 (-2.72 to -0.23)	-34 (-110 to 176)	19 (-36 to 72)*	8 (-8 to 30)
Upadacitinib 30mg (High Dose)	-13.99 (-16.62 to -11.37)	-8.26 (-9.41 to -7.30)	-3.91 (-5.35 to -2.49)		-9.76 (-11.23 to -8.38)	-125 (-132 to -111)	108 (72 to 141)*	-4 (-11 to 7)*
Upadacitinib 15mg (Low Dose)	-11.41 (-14.22 to -8.64)	-8.54 (-9.64 to -7.43)	-1.90 (-2.33 to -1.45)		-3.36 (-4.83 to -1.89)	-115 (-124 to -101)	55 (14 to 95)*	-3 (-12 to 7)*
UV Light Therapy								
Narrow-Band UVB	-5.43 (-11.68 to 0.77)			-3.30 (-4.06 to -2.59)				
UVA1/UVB Therapy	1.90 (-3.42 to 7.07)			-1.60 (-3.25 to 0.04)	-5.80 (-10.19 to -1.36)		-140 (-331 to 821)	36 (-21 to 874)
Other								
Oral Corticosteroid	-4.28 (-14.70 to 6.18)	-3.76 (-10.72 to 3.11)	-0.97 (-2.20 to 0.24)	-0.58 (-1.76 to 0.56)	-4.30 (-9.36 to 0.77)	113 (-134 to 824)		190 (-18 to 955)
Montelukast	-1.45 (-6.50 to 4.44)		0.71 (-0.54 to 1.97)	0.61 (-0.71 to 1.92)			-8 (-51.5 to 38.8)	42 (-19 to 614)

High to moderate certainty evidence	Low to very low certainty evidence
Among the most effective	Possibly among the most effective
Among the intermediate (superior) effective	Possibly among the intermediate (superior) effective
Among the intermediate (inferior) effective	Possibly among the intermediate (inferior) effective
Not clearly different from placebo	Possibly not clearly different from placebo
Among the intermediate harmful	Possibly among the intermediate harmful
Among the most harmful	Possibly among the most harmful

○ [Drucker AM, et al. NMA]³⁴⁾ 2023년 12월 3일까지 검색된 전신 면역조절제를 8주 이상 투여한 중등도에서 중증 아토피피부염 환자를 대상으로 한 무작위배정 임상시험 97개, 24,679명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,

- (유효성_성인) 16주째 결과에서

- 신청품³⁵⁾은 dupilumab³⁶⁾ 대비 EASI 감소(MD, -2.0; 95% CrI, -4.5 to 0.3; moderate certainty), POEM³⁷⁾(MD, -1.1; 95% CrI, -2.5 to 0.2; moderate certainty), DLQI³⁸⁾(MD, -0.2; 95% CrI, -2.1 to 1.6;

34) Drucker AM, et al. Systemic Immunomodulatory Treatments for Atopic Dermatitis: Living Systematic Review and Network Meta-Analysis Update. JAMA Dermatol. 2024;160(9):936-944.

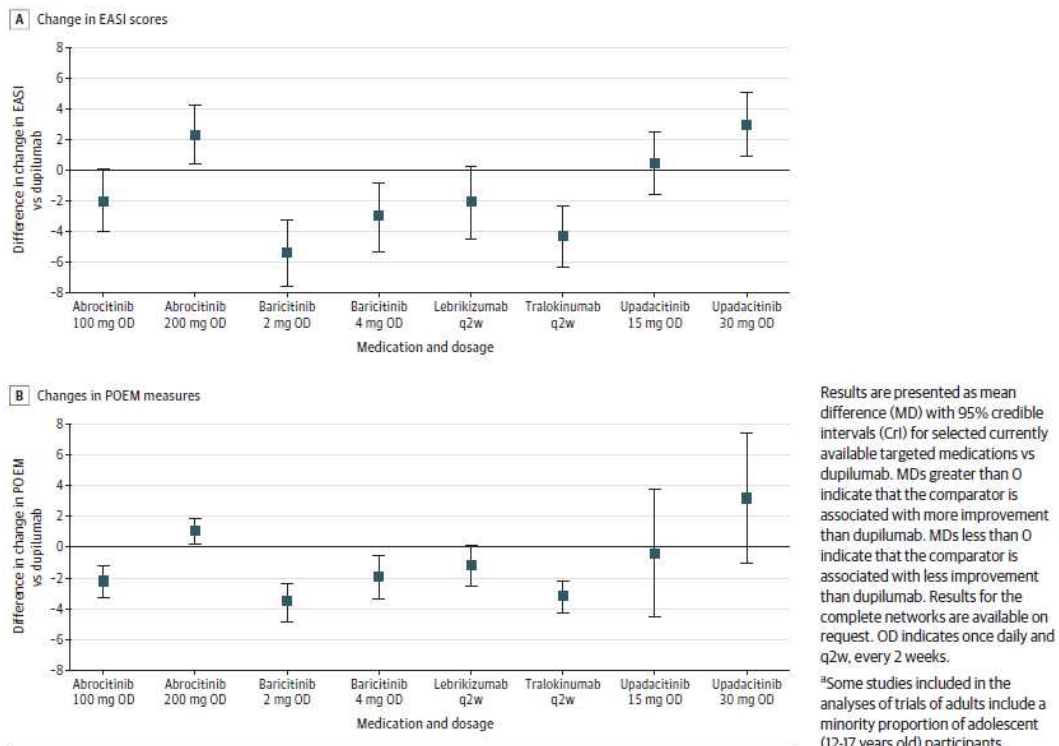
35) lebrikizumab: 500mg at weeks 0 and 2 followed by 250mg every 2weeks

36) dupilumab: 600mg followed by 300mg every 2weeks

37) 소양증 평가지표, Patient-reported atopic dermatitis severity (Patient-Oriented Eczema Measure, POEM)

moderate certainty), PP-NRS³⁹⁾(MD 0.1; 95% CrI, -0.4 to 0.6; high certainty)에서 유의미한 차이가 없는 것으로 분석됨.

- dupilumab이 EASI-50 (OR 1.4; 95% CrI, 1.0 to 2.0), EASI-75 (OR 1.4; 95% CrI, 1.0 to 1.9), EASI-90 (OR 1.5; 95% CrI, 1.1 to 2.2), IGA 달성 (OR 1.3; 95% CrI, 0.9 to 1.9)에서 신청품보다 더 좋은 효과를 보임.
- (결론) 신청품은 성인 아토피 피부염과 관련된 징후, 증상 및 삶의 질 향상에 있어 moderate certainty 수준으로 dupilumab과 16주차까지 유사한 효과를 보이며, dupilumab이 신청품보다 binary outcome⁴⁰⁾에서 더 높은 효과 달성 가능성을 보임.



38) 피부질환자의 삶의 질 평가지표, AD-related quality of life (Dermatology Life Quality Index, DLQI)

39) 소양증 평가지표, prioritizing peak pruritus numeric rating scales (PP-NRS)

40) 4 binary efficacy outcomes: the proportion of patients with 50%, 75%, and 90% improvement in EASI (EASI-50, -75, -90) and **success on the Investigator Global Assessment (IGA) scales**, prioritizing a reduction of 2 points and score of 0 or 1

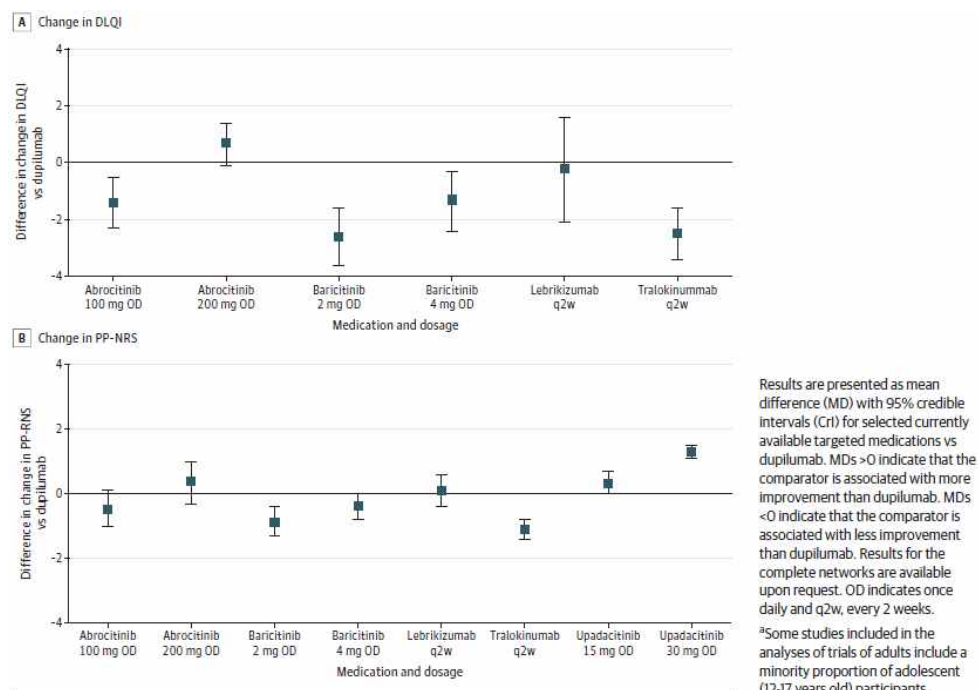


Table 10. Relative effect estimates for success achieving 75% improvement in EASI (EASI-75) up to 16 weeks of treatment in adults for placebo and medications used in clinical practice. Results for other pairwise comparisons in the network can be requested from the authors. Results are presented as odds ratios (95% credible intervals). Values over 1 indicate greater efficacy for the column-defined treatment. Values less than 1 indicate greater efficacy for the row-defined treatment.

	Abro 100	Abro 200	Bari 2	Bari 4	Dupi	Lebri	Placebo	Tralo	Upa 15	Upa 30
Abro 100		2.1 (1.6, 2.8)	0.6 (0.4, 0.9)	0.7 (0.4, 1)	1.3 (1, 1.8)	1 (0.6, 1.5)	0.2 (0.2, 0.3)	0.5 (0.3, 0.7)	1.7 (1.1, 2.5)	2.8 (1.9, 4.1)
Abro 200	0.5 (0.4, 0.6)		0.3 (0.2, 0.4)	0.3 (0.2, 0.5)	0.6 (0.5, 0.8)	0.5 (0.3, 0.7)	0.1 (0.1, 0.1)	0.2 (0.2, 0.3)	0.8 (0.5, 1.1)	1.3 (0.9, 1.9)
Bari 2	1.8 (1.1, 2.7)	3.7 (2.5, 5.7)		1.2 (0.9, 1.6)	2.3 (1.6, 3.3)	1.7 (1.2, 2.6)	0.4 (0.3, 0.5)	0.9 (0.6, 1.3)	2.9 (2, 4.3)	4.9 (3.4, 7.2)
Bari 4	1.5 (1, 2.4)	3.2 (2.1, 5)	0.9 (0.6, 1.2)		2 (1.4, 2.9)	1.5 (1, 2.3)	0.3 (0.2, 0.5)	0.8 (0.5, 1.1)	2.5 (1.7, 3.8)	4.3 (2.9, 6.4)
Dupi	0.8 (0.5, 1)	1.6 (1.2, 2.1)	0.4 (0.3, 0.6)	0.5 (0.3, 0.7)		0.7 (0.5, 1)	0.2 (0.1, 0.2)	0.4 (0.3, 0.5)	1.2 (0.9, 1.7)	2.1 (1.6, 2.8)
Lebri	1 (0.7, 1.6)	2.2 (1.5, 3.2)	0.6 (0.4, 0.9)	0.7 (0.4, 1)	1.4 (1, 1.9)		0.2 (0.2, 0.3)	0.5 (0.3, 0.7)	1.7 (1.2, 2.5)	2.9 (2, 4.1)
Placebo	4.6 (3.4, 6.4)	9.8 (7.4, 13.3)	2.6 (2, 3.5)	3 (2.2, 4.2)	6.2 (5, 7.5)	4.5 (3.5, 6)		2.3 (1.8, 2.9)	7.7 (5.9, 10)	12.9 (10.2, 16.6)
Tralo	2 (1.4, 3)	4.3 (2.9, 6.4)	1.1 (0.8, 1.7)	1.3 (0.9, 2)	2.7 (2, 3.7)	2 (1.4, 2.9)	0.4 (0.3, 0.6)		3.3 (2.3, 4.8)	5.6 (4, 8.1)
Upa 15	0.6 (0.4, 0.9)	1.3 (0.9, 1.9)	0.3 (0.2, 0.5)	0.4 (0.3, 0.6)	0.8 (0.6, 1.1)	0.6 (0.4, 0.9)	0.1 (0.1, 0.2)	0.3 (0.2, 0.4)		1.7 (1.3, 2.2)
Upa 30	0.4 (0.2, 0.5)	0.8 (0.5, 1.1)	0.2 (0.1, 0.3)	0.2 (0.2, 0.3)	0.5 (0.4, 0.6)	0.4 (0.2, 0.5)	0.1 (0.1, 0.1)	0.2 (0.1, 0.2)	0.6 (0.5, 0.8)	
SUCRA	0.74	0.93	0.53	0.59	0.83	0.73	0.14	0.47	0.89	0.97

Abro 100/200: abrocitinib 100 mg/200 mg daily; bari 2/4: baricitinib 2mg/4 mg daily; dupi: dupilumab 600 mg then 300 mg every 2 weeks; lebri: lebrikizumab 500 mg at week 0 and 2 then 250 mg every 2 weeks; tralo: tralokinumab 600 mg then 300 mg every 2 weeks; upa 15/30: upadacitinib 15mg/30 mg daily.

○ [Silverberg JI, et al. NMA]⁴¹⁾ 국소 치료제에 반응이 불충분하거나 부적절한 중등도에서 중증 아토피피부염 환자의 무작위배정 시험 중 6개의 targeted systemic therapies⁴²⁾을 평가한 13개 시험을 포함하여 7,105명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,

- (유효성) EASI-90에서는 upadacitinib이 가장 높은 효과를 보였으며, dupilumab은 4번째, 신청품은 7번째로 높은 효과를 보임. EASI-75 역시 upadacitinib이 가장 높은 효과를 나타냈으며, 신청품은 4번째로 높은 효과를 나타냄. 또한, IGA 0/1 response rate는 dupilumab이 4번째, 신청품이 5번째로 높은 효과를 보였음.

▪ 신청품은 dupilumab, abrocitinib 100mg, baricitinib 4mg과 유사한 효과를 보였음.

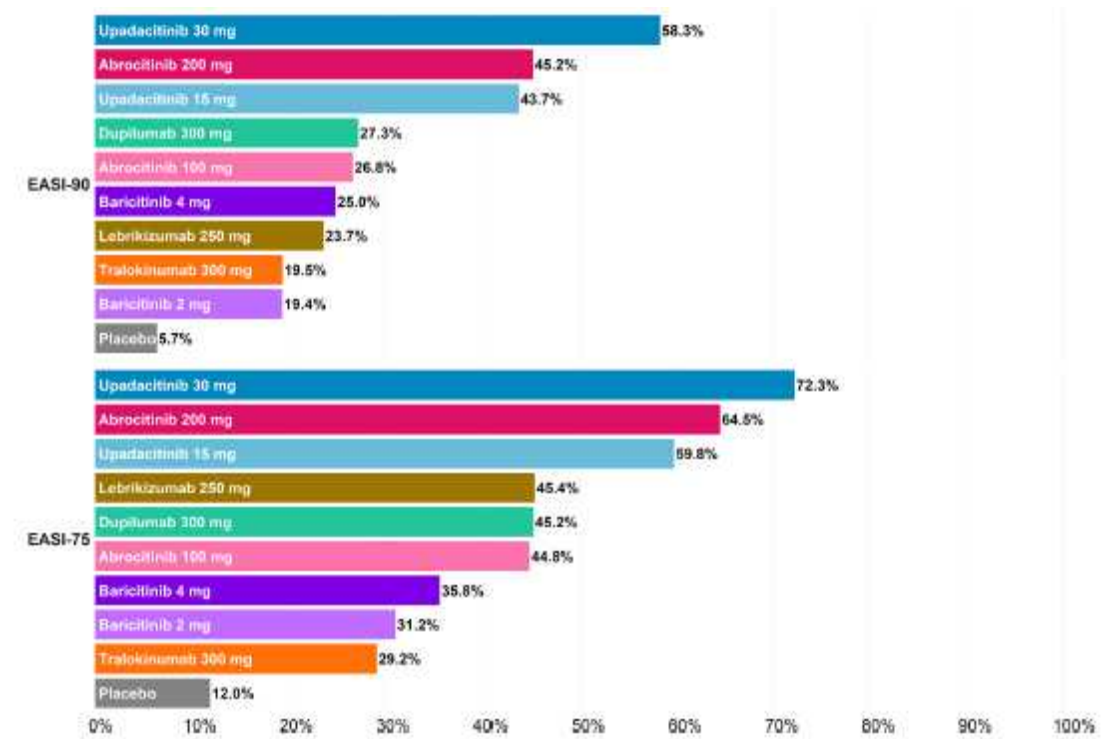


Fig. 2 EASI-75 and EASI-90 absolute response rate estimates for moderate-to-severe atopic dermatitis (primary endpoint timepoint). *EASI* Eczema Area and Severity Index, *EASI-75* EASI improvement $\geq 75\%$ from baseline, *EASI-90* improvement $\geq 90\%$ from baseline

41) Silverberg JI, et al. Comparative Efficacy of Targeted Systemic Therapies for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis without Topical Corticosteroids: An Updated Network Meta-analysis. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2023;13(10):2247-2264.

42) abrocitinib, baricitinib, dupilumab, lebrikizumab, tralokinumab, upadacitinib

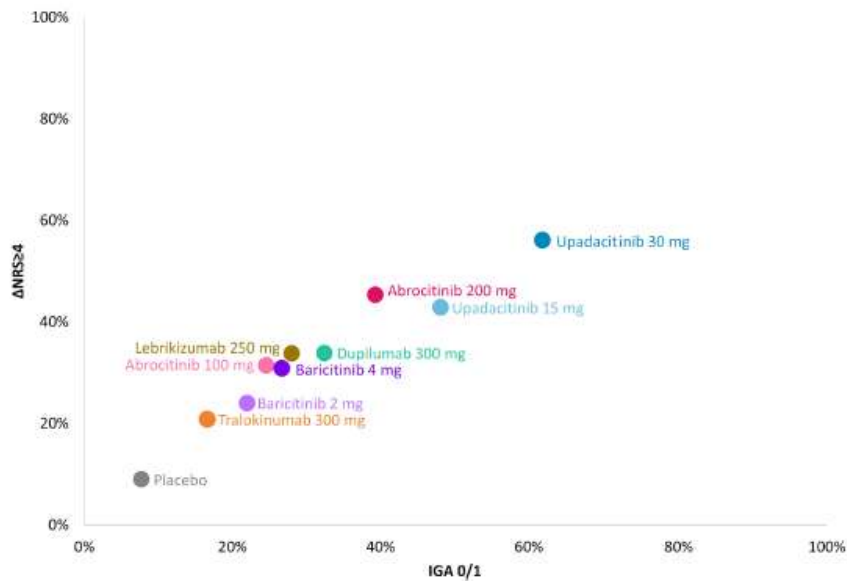


Fig. 3 IGA 0/1 versus Δ NRS ≥ 4 absolute response rate estimates for moderate-to-severe atopic dermatitis (primary endpoint timepoint). IGA Investigator Global Assessment for Atopic Dermatitis, IGA 0/1 score of 0 or 1 (clear or

almost clear) and reduction of ≥ 2 points from baseline, Δ NRS ≥ 4 Pruritus Numerical Rating Scale reduction of ≥ 4 points from baseline

○ [MAIC_dupilumab]⁴³⁾ 16주차(induction period)에 치료효과를 달성한 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자에서 유지기간(16주-52주) 동안 신청품(lebrikizumab 250mg Q4W)과 비교대안(dupilumab 300mg QW/Q2W)간의 장기 효과와 안전성을 비교하기 위한 unanchored MAIC 결과⁴⁴⁾,

- [결과] 36주 동안(16주-52주) IGA 0/1 유지율이 dupilumab 대비 신청품에서 더 높은 것으로 나타났으며(RR 1.334, 95% CI 1.02-1.74, p=0.035), EASI-75 유지율(RR 0.937, 95% CI 0.78-1.13, p=0.490)과 이상반응 발생률(RR 1.052, 95% CI 0.90-1.23, p=0.526)은 두 군이 유

43) Rand K, et al. Matching-Adjusted Indirect Comparison of the Long-Term Efficacy Maintenance and Adverse Event Rates of Lebrikizumab versus Dupilumab in Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(1):169-182.

44) ADvocate1/2 study와 SOLO-CONTINUE trial 간의 간접비교

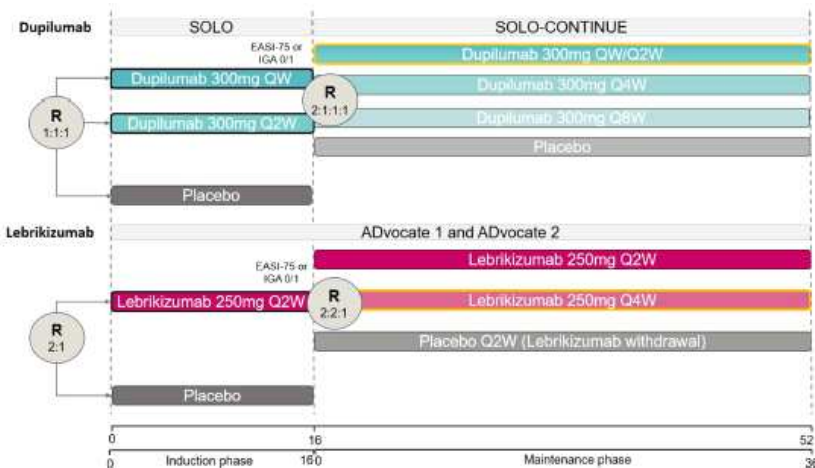


Fig. 1 ADvocate and SOLO-CONTINUE trial designs. The arms used in this study are outlined in gold

사한 것으로 나타남.

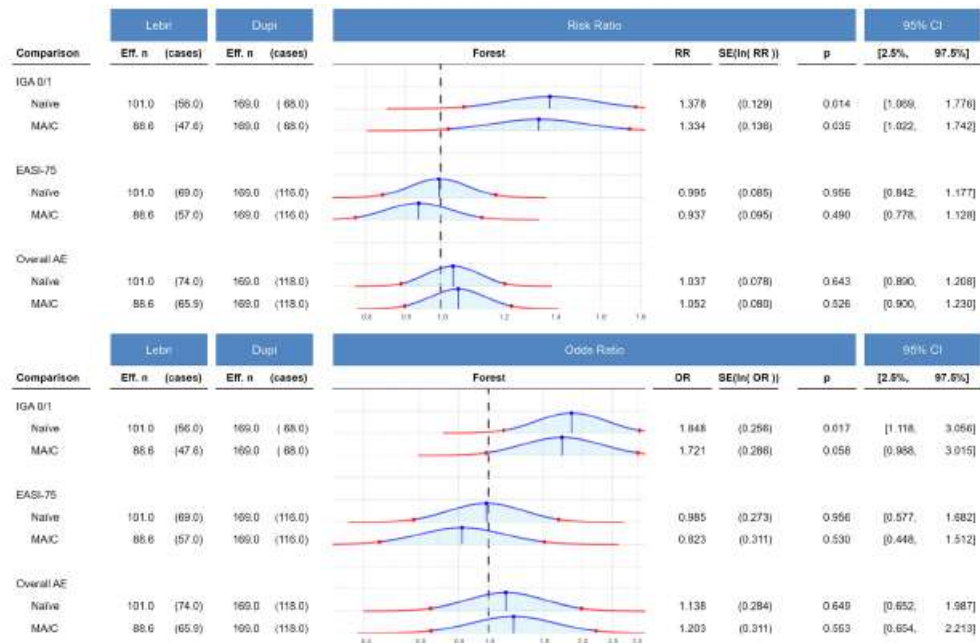


Fig. 3 Risk and odds ratio forest plots for MAIC and naïve comparisons. *Lebri* lebrikizumab, *Dupi* dupilumab, *CI* confidence Interval, *SE* standard error, *RR* relative risk/risk ratio, *OR* odds ratio, *0/1* Score of 0 or 1 on Investigator's Global Assessment, *EASI-75* 75% improvement in score on the Eczema Area and Severity Index, *MAIC* matching-adjusted indirect comparison, *AE* adverse events

(5) 학회 의견⁴⁵⁾

- 신청품은 ‘중등도-중증 성인 및 청소년 아토피피부염’의 치료에 허가된 약제로, 신청품은 주요 3상 임상시험을 통해 효과 및 안전성을 입증하였으며, 투여 간격의 증가 등 사회적 관점에서 편익이 존재하며, 신청품의 임상연구 문헌 결과를 바탕으로 향후 교과서 및 가이드라인에서 권고될 가능성이 높음.
- 또한, 신청품의 허가사항 및 급여기준과 동일하게 사용되고 있는 약제는 생물학적 제제와 JAK 억제제가 있으나, 작용기전에 차이가 있으므로 치료적 위치를 고려한 신청품의 대체약제로는 생물학적 제제(dupilumab, tralokinumab)로 생각된다는 의견임.
 - 아울러, 아토피피부염은 환자마다 증상이 다르며 유사한 기전이라도 환자마다 효과적인 약제는 다를 수 있으므로 기존 치료제에 실패할 경우 계열간(생물학적 제제와 JAK 억제제) 및 계열 내의 교차투여가 허용되어야 한다는 의견을 제시함.

45) 대한피부과학회(), 대한천식알레르기학회(), 대한소아알레르기호흡기학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “성인 및 12세 이상의 청소년(체중 40kg 이상)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증의 아토피 피부염의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 dupilumab, tralokinumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

○ 2024년 제11차 약제급여기준 소위원회(일자: 2024년 11월 26일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[142] Lebrikizumab 주사제 (품명 : 엠플리스 오토인젝터주 250밀리그램)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 3년 이상 증상이 지속되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세 -만 17세, 체중 40kg 이상) 만성 중증 아토피피부염 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 1차 치료제로 국소치료제(중등도 이상의 코르티코스테로이드 또는 칼시뉴린 저해제)를 4주 이상 투여하였음에도 적절히 조절되지 않고, 이후 전신 면역억제제(Cyclosporine 또는 Methotrexate)를 3개월 이상 투여하였음에도 반응(EASI(Eczema Area and Severity Index) 50%이상 감소)이 없거나 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우 * 동 약제 투약개시일 6개월 이내에 국소치료제 및 전신 면역억제제 투여이력이 확인되어야 함. 2) 동 약제 투여시작 전 EASI 23 이상 나. 평가방법 1) 동 약제를 14주간 투여 후 16주째 평가하여 EASI가 75%이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 2) 이후에는 지속적으로 6개월마다 평가하여 최초 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 다. 교체투여 1) 동 약제에 효과가 없거나 부작용 등으로 투약을 지속할 수 없는 경우(교체한 약제는 최소 6개월 투여 유지 권고)에는 JAK 억제제*로 교체투여를 인정하며, 이 경우에는 투여소견서를 첨부하여야 함. * JAK 억제제(Janus kinase inhibitor): Abrocitinib, Baricitinib,

구 분	세부인정기준 및 방법
	Upadacitinib 경구제 2) Dupilumab 주사제 또는 Tralokinumab 주사제와의 교체투여는 인정하지 않음. 라. 원내처방을 원칙으로 하며, 퇴원 시 및 외래에서의 1회 처방기간은 최대 4주 분까지로 함. – 단, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우에는 최대 8~12주분까지 인정함. 마. 동 약제는 자가주사제인 점을 고려하여, 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함. 바. 동 약제는 아토피 관련 진료과(피부과, 알레르기내과, 소아알레르기호흡기) 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(약제투여 과거력, EASI 산출근거, 환부 사진 등)를 반드시 제출하여야 함.

(8) 제외국 등재 현황

☐ 신청품은 A8 국가 중 4개국 약가집(미국, 영국, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.

☐ 제외국 평가결과

○ NICE (2024년 7월): Recommended(commercial arrangement)

- 신청품은 전신요법의 대상이 되고, 이전에 적어도 1개 이상의 전신 면역억제제에 반응하지 않거나, 이들 치료제가 권장되지 않는 12세 이상(40kg 이상) 중등도에서 중증의 아토피피부염 환자의 치료에 권고됨.
 - 16주 이후 평가에서 EASI 50을 달성하지 못하거나 기저치 대비 DLQI(Dermatology Life Quality Index)가 4점 이상 감소하지 않으면 신청품을 중단해야 함.
 - 신청품은 임상시험에서 위약 대비 아토피피부염의 증상 개선에 효과적이었으며, 표준 치료와의 직접비교 자료는 없으나, JAK inhibitor와 생물학적제제와의 간접비교를 통하여 신청품의 효과가 유사함을 인정함.
 - 신청품의 생물학적제제(dupilumab or tralokinumab)와의 비용효과성 평가(CUA)에서 NMA를 사용하는 등 자료원의 불확실성이 존재하므로 수용 가능한 ICER수준은 £20,000/QALY 이하로 평가하였으며, 신청품의 경제성평가 결과 ICER가 £20,000/QALY 이하로 수용 가능함.

○ SMC(2024년 8월): Accepted for restricted use(PAS arrangement)

- 신청품은 전신요법의 대상이 되고, ciclosporin과 같은 전신 면역억제제에 반응하지 않거나, 이들 치료제가 권장되지 않는 12세 이상(40kg 이상)의 중등도-중증의 아토피피부염 환자의 치료에 권고됨.
 - 신청품은 임상시험에서 위약 대비 중등도-중증의 아토피피부염 환자에서 단독요법 또는 국소 코르티코스테로이드와의 병용요법에서 증상 개선 효과를 나타냄.
 - 신청품은 비교 가능한 약제(JAK inhibitor, 생물학적제제)와 직접비교 결과는 없으며, NMA에서 dupilumab, tralokinumab과 유사한 효과를 보였으나, JAK inhibitor와의 효과 비교는 불분명함.
 - 신청품은 JAK inhibitor(abrocitinib, baricitinib, upadacitinib)와 생물학적제제(dupilumab, tralokinumab)와의 비용효과성 평가 결과를 고려하여 PAS arrangement를 통한 제한적 사용을 권고함.

○ CADTH (2024년 11월): Do not reimburse

- CADTH는 신청품이 아토피피부염의 치료제로 공적보험이 적용되기에는 부적절한 것으로 평가함.
 - 신청품은 중등도-중증의 12세 이상 청소년 및 성인 아토피피부염 환자에서 위약 대비 증상 개선 효과를 보였으나, 적절한 비교대안(현재 치료법)과의 직접비교가 없고, 제출된 간접비교 자료는 불확실성이 크며, 이전에 JAK inhibitor와 dupilumab을 사용한 환자에서의 신청품의 효과가 불분명하여 현재 아토피피부염 환자의 unmet needs를 충족하지 못함.
 - ✓ CADTH는 현재 중등도-중증 아토피피부염 환자의 unmet needs는 다른 생물학적제제 및 JAK inhibitor에 적절히 반응하지 않는 환자에서의 추가적인 치료 옵션임.
 - 아토피피부염의 치료에서 다른 치료법 대비 신청품의 안전성이 불분명하며, 임상시험 설계 및 가용한 증거 자료원의 부족으로 신청품의 장기 안전성 및 효과가 불확실함.

○ PBAC(2024년 3월): Recommended

- 신청품은 12세 이상의 청소년 및 성인의 중증 아토피피부염 치료에 권고됨.
 - PBAC은 중증의 아토피피부염에서의 추가적인 전신 치료 옵션에 대하여 임상적 필요도를 인정하였고, 신청품은 비교약제(dupilumab, upadacitinib)와 직접비교 임상시험이 부재하여 간접비교 결과의 불확실성이 있으나, 비교약제와 효과가 유사함을 인정함. 따라서, 비교약제와의 CMA 결과에 따른 약가로 급여 등재를 권고함.
 - CMA 평가에서 'slow responders(34.48%)'에 대한 용량을 고려하였고, 이러한 slow responders는 신청품을 24주차까지 2주 간격으로, 이후 유지용량으로 4주 간격으로 투여하는 것으로 용량 및 비용을 계산하여 반영하였으며, 추후 위험분담제 계약(subsidisation cap)의 필요성이 있음을 언급함.
 - 신청품은 dupilumab 또는 upadacitinib과 교체 투여하지 말 것을 권고함.